EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 92857
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-09-16 08:07:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: DANIEL ORLANDO JORQUERA TAPIA			RUN	: 13.208.159-K
F.Nac	: 07-09-1977	Edad	: 47 AÑOS	Género	: Masculino
Dirección	: CALLE STA TERESA 674 DOÑA JAVIERA 3			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 945685199		
Fecha Ingreso	: 2024-08-23	Fecha Egreso	: 2024-09-16 08:07:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. A41.9-SEPTICEMIA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. Shock séptico, resuelto
- Bacteriemia por Klebsiella pneumoniae MS
- Sospecha de Absceso Hepático
2. Lesión renal aguda KDIGO1, resuelta
3. Trombopenia reactiva, recuperado
4. Derrame Pleural bilateral + Atelectasias bibasales.
5. Insuficiencia cardiaca congestiva FEc
6. Antecedentes: TU cabeza de páncreas operado (Cx Whipple 2010)

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. R57.2-CHOQUE SEPTICO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente de 46a sin antecedentes mórbidos operado de whipple 2010 por tu cabeza de páncreas ingresa por clínica de 3 días de evolución caracterizado por compromiso del estado general y calofríos (Sin tos, sin disnea, sin vómitos, sin nauseas, sin diarrea sin odinofagia o sintomatología irritativa urinaria). Ex lab actuales con DD elevado, PCT elevada, deterioro fx renal y px hepáticas con hiperbli indirecta con discreto patrón hepatocelular, lactato 6, PCR >300 y plaquetopenia leve, INR 1.8 y acidosis metabólica leve compensada. TAC AP, sin hallazgos patológicos. Impresiona hepatomegalia importante. Concomitantemente paciente refiere que estuvo limpiando bodega los días 19 y 20/08/24 en parral en lugar urbano colindante con rural, donde había fecas de ratón. Se ingresa a la unidad para monitoreo titular DVA, y se toma panel viral negativo, pumala negativo, se solicita test de leptospira IgM y IgG. Se notifica en Epivigila.
Evoluciona favorablemente Se rescata resultado de HC (+) para Klebsiella pneumoniae MS, antibiograma sin mención a carbapenémicos, sensible a Ceftriaxona. TC de abdomen y pelvis con lesión focal hepática derecha, cuyas características sugieren como 1ª posibilidad absceso (menor a 3 cm), sin descartar localización secundaria. Coprocultivo (-). Mantener esquema antibiótico a Ceftriaxona y metronidazol (de corresponder absceso, tto es por 4 semanas mínimo.
RMN 6.9.24: Lesion focal Heptica central, cuyas carcateristicas de señales y realce favorecen una lesion inflamatoria(Absceso en fase de organizacion). Se suiere control evolutivo. Esteatosis hepatica geografica. Quiste Hepaticos Simples Bilobares. Pequeños Quistes Corticales Renales Bilaterales y uno parapielico Izquierdo de Aspecto Simple.
Evaluado por Cirugia: Completando Cobertura Antibiótica Por 4 Semanas. Sin Indicacion De Cirugia Actual. Control Policlínico Cirugia Al Alta.
Al examen físico en estables condiciones generales. Afebri, normocardico, normotenso. Niega dolor, nauseas, vómito, mareo o algún otro signo o síntoma asociado. Diuresis + Deposiciones +. Bien

hidratado y perfundido, moderada palidez cutaneo mucosa. Cardiopulmonar: torax expansible mp presente sin agregados RsCsRs NAS. Abdomen: plano RHA+ blando, depresible, sin dolor ni masas palpables. Extremidades: sin edema ni signos de TVP. Neurologico: Vigil, orientado, glasgow 15 ptos

PLAN DE MANEJO:

ALTA CON HODOM
MANTENER TTO ATB POR 10 DIAS
CONTROL POLI DE CIRUGIA EN 15 DIAS
CONTROL SOS URGENCIA

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo asistido
2. Regimen liviano
3. OMEPRAZOL COMPRIMIDO 20 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
4. CEFTRIAXONA FRASCO 1 GRAMO 2 frasco cada 24 hrs. por 10 dias via ENDOVENOSA
5. METRONIDAZOL COMP 500 MILIGRAMO cada 8 hrs. por 10 dias via
6. PARACETAMOL COMPRIMIDO 500 MILÍGRAMOS SOS

EXÁMENES Y RESULTADOS

RMN 6.9.24: Lesion focal Heptica central, cuyas carcateristicas de señales y realce favorecen una lesion inflamatoria(Absceso en fase de organizacion). Se suiere control evolutivo. Esteatosis hepatica geografica. Quiste Hepaticos Simples Bilobares. Pequeños Quistes Corticales Renales Bilaterales y uno parapielico Izquierdo de Aspecto Simple.
RX TX AP: sin alteraciones.
10.9.24 : Crea: 0,90 | FA: 94 | BI: 0,26 | BD: 0,34 * | BT: 0,60 | GOT: 36 | GPT: 57 * | GGT: 120 * | Clearence MDRD: 90,45 | PCR: 5,6 | Uremia: 36 | Na: 139 | K: 4,80 | Cl: 103 | GB: 4,60 | RBC: 4,60 | Hto: 41,7 | Hb: 14,1 | VCM: 90,7 | HCM: 30,7 | CHCM: 33,8 | RDW: 13,5 | PLT: 647 * | Seg: 46 | Linfo: 42 | Mono: 8 | Eos: 1 | Baso: 3 * | VHS: 35 | INR: 1,05 | TP%: 92 | TP: 14,0 | TTPA: 29 | PCT: 0,10
Hemocultivos de control negativos. Parámetros inflamatorios negativos
05/09/24: Sin examenes
04/09/24: Crea 0.70, PCR 32.2, ELP 140/5.1/104, Hcto 36, Hb 12.4, INR 1.14
02/09/24: Crea 0.8 PCR 69 Uremia 43 ELP 142/4.7/106 Hb 12 GB 5800 PQT 649 mil
01/09/24: Glicemia 116 Crea 0.8 PCR 141 Uremia 43 ELP 140/5.1/105 GB 10500 Hb 12.2 PQT 544mil
Sin laboratorios control hoy 31/08/24.
28/08/24: Crea 0.9 PCR 243 Hb12.6 PQT 147 mil
27/08/24: Crea 0.7 PCR 153 Uremia 29 ELP 137/3.7/106 GB 9500 PQT 75 mil Hb 12 INR 1.04 ProBNP 4290 GSA pH 7.50 pCO2 27.5 pO2 57.4 Bic 21.5 sat 90% FiO2 24%.
26/08/24: Glicemia 98 Albumina 2.3 Crea 0.9 PCR 218 CaC 8.86 Lactato 0.8 Uremia 44 ELP 138/3.8/109 GB 7700 Hb 12.1 PQT 55 mil INR 1.20 TTPK 31% GSA pH 7.48 pCO2 28 pO2 72 Bic 19 sat 94% FiO2 28%.
AngioTC Torax (26/08/24): Examen sin evidencias de tromboembolismo pulmonar. Edema pulmonar asociado a moderado derrame pleural bilateral.
Signos sugerentes de absceso hepático en formación. Correlacionar clínicamente.
TC AP (23/08/24): Lesión hepática de aspecto secundario.
TC AP (28/08/24): Lesión focal hepática derecha, cuyas características sugieren como 1ª posibilidad un origen inflamatorio infeccioso (absceso). Una localización secundaria de un primario no visualizado en este estudio no es completamente descartable aunque parece menos probable. Se sugiere control evolutivo para documentar resolución completa. Derrame pleural bilateral con atelectasia pasiva en lóbulos inferiores visibles Resto sin variaciones.

CARABALLO DE HURTADO
JENNIFER DEL CARMEN
MEDICO TRATANTE
26251544-3

JEFE SERVICIO